

SENTETİK ÖRNEK HASTANESİ
YOĞUN BAKIM EPİKRİZ RAPORU

Adı - Soyadı : ÖRNEK HASTA İKİ Prot / Dosya No : 99002 / 700002

TC Kimlik No : 11111111111

Cinsiyeti - Yaş : KADIN - 71

D.Tarihi : 08.07.1953

Kurum : ÖZEL

Bölüm Adı : Genel Yoğun Bakım Yatış Tarihi : 12.05.2023

Çıkış Tarihi : 20.05.2023

Taburcu Şekli : Şifa ile taburcu

Kesin Tanı : Ürosepsis, septik şok, kronik böbrek hastalığı

Apache II skoru: 19

tanısal ölüm oranı %33

Tip 2 diyabet ve kronik böbrek hastalığı öyküsü olan hasta, ateş, titreme ve bilinç bulanıklığı ile getirildi; ürosepsis ve septik şok tablosuyla yoğun bakıma kabul edildi. Mesane sondası takıldı, saatlik idrar takibine alındı.

12.05.2023 1.GÜN

Ürosepsis ve septik şok tanılarıyla izlenen hastanın genel durumu kötü, GKS 10, pupiller izokorik, IR +/- . Yüksek akımlı oksijen ve aralıklı noninvasiv ventilasyon mekanik ventilatör desteğinde; dinlemekle her iki akciğer solunum sesleri kaba ve bilateral azalmış. TA 85/50 mmHg, nabız 118/dk, ateş 38.9 C. Laboratuvar: lökosit 22500, CRP 280, kreatinin 3.6, üre 180, laktat 3.1, trombosit 110000. Sıvı resüsitasyonu sonrası noradrenalin ve düşük doz dopamin infüzyonu başladı. Antibiyoterapi enfeksiyon hastalıkları onayıyla Meronem 3x1gr (1.gün). Kan gazı: ph 7.28 pco2 34 po2 70 hco3 17 be -7 spo2 90 sodyum 133 potasyum 5.1. Kan şekerleri 190-240 mg/dl seyretti, kristalize insülin ile regüle edildi. İdrar çıkışı diüretik infüzyonu ile yeterli, AÇT -200/24saat, CVP +1. Oligürik seyir, hemodiyaliz planlandı. Solunum fizyoterapisi, vücut ve kateter bakımları yapıldı. Mevcut medikal, hemodinamik ve solunum destek tedavisine devam edildi. GLASGOW Skalası Gözler : 3 Sözel : 2 Motor : 5

14.05.2023 2.GÜN

Ürosepsis, septik şok tanılarıyla izlenen hastanın genel durumu kötü-orta, GKS 11, pupiller izokorik, IR +/- . Aralıklı noninvasiv ventilasyon, oksijen desteği mekanik ventilatör desteğinde; dinlemekle her iki akciğer solunum sesleri kaba ve bilateral azalmış. TA 98/58 mmHg, nabız 110/dk, ateş 38.2 C. Laboratuvar: lökosit 18000, CRP 220, kreatinin 3.0, üre 150, laktat 2.4, trombosit 150000. Noradrenalin sürüyor, dopamin azaltıldı; bir seans hemodiyaliz uygulandı. Antibiyoterapi enfeksiyon hastalıkları onayıyla Meronem 3x1gr (3.gün). Kan gazı: ph 7.31 pco2 36 po2 78 hco3 19 be -5 spo2 92 sodyum 135 potasyum 4.7. Kan şekerleri 170-220 mg/dl seyretti, kristalize insülin ile regüle edildi. İdrar çıkışı diüretik infüzyonu ile yeterli, AÇT +100/24saat, CVP +3. Parenteral beslenme (+). Solunum fizyoterapisi, vücut ve kateter bakımları yapıldı. Mevcut medikal, hemodinamik ve solunum destek tedavisine devam edildi. GLASGOW Skalası Gözler : 3 Sözel : 3 Motor : 5

16.05.2023 3.GÜN

Ürosepsis, yanıt alınıyor tanılarıyla izlenen hastanın genel durumu orta, GKS 14, pupiller izokorik, IR +/- . Nazal oksijen, spontan solunum mekanik ventilatör desteğinde; dinlemekle her iki akciğer solunum sesleri kaba ve bilateral azalmış. TA 118/70 mmHg, nabız 92/dk, ateş 37.6 C. Laboratuvar: lökosit 14100, CRP 150, kreatinin 2.4, üre 120, laktat 1.8, trombosit 190000. Hemodinamik toparlanma ile dopamin kesildi, noradrenalin azaltıldı; ikinci hemodiyaliz yapıldı. Antibiyoterapi enfeksiyon hastalıkları onayıyla Meronem 3x1gr (5.gün), Kolistin 3x150mg (1.gün). Kan gazı: ph 7.35 pco2 38 po2 85 hco3 21 be -2 spo2 94 sodyum 137 potasyum 4.3. Kan şekerleri 150-200 mg/dl seyretti, kristalize insülin ile regüle edildi. İdrar çıkışı diüretik infüzyonu ile yeterli, AÇT +150/24saat, CVP +3. Enteral beslenme başladı. Solunum fizyoterapisi, vücut ve kateter bakımları yapıldı. Mevcut medikal, hemodinamik ve solunum destek tedavisine devam edildi. GLASGOW Skalası Gözler : 4 Sözel : 4 Motor : 6

18.05.2023 4.GÜN

Ürosepsis, düzelme tanılarıyla izlenen hastanın genel durumu orta-iyi, GKS 15, pupiller izokorik, IR +/- . Oda havasında, ek oksijen minimal mekanik ventilatör desteğinde; dinlemekle her iki akciğer solunum sesleri kaba ve bilateral azalmış. TA 122/72 mmHg, nabız 86/dk, ateş 37.1 C. Laboratuvar: lökosit 9800, CRP 90, kreatinin 1.9, üre 95, laktat 1.4, trombosit 240000. Vazopressör ihtiyacı azaldı; renal fonksiyonlar diyalizsiz stabil. Antibiyoterapi enfeksiyon hastalıkları onayıyla Meronem 3x1gr (7.gün), Kolistin 3x150mg (3.gün). Kan gazı: ph 7.38 pco2 40 po2 90 hco3 23 be -1 spo2 96 sodyum 138 potasyum 4.2. Kan şekerleri 140-180 mg/dl seyretti, kristalize insülin ile regüle edildi. İdrar çıkışı diüretik infüzyonu ile yeterli, AÇT +200/24saat, CVP +2. Enteral beslenme tam doz. Solunum fizyoterapisi, vücut ve kateter bakımları yapıldı. Mevcut medikal, hemodinamik ve solunum destek tedavisine devam edildi. GLASGOW Skalası Gözler : 4 Sözel : 5 Motor : 6

20.05.2023 5.GÜN

Ürosepsis, iyileşme tanılarıyla izlenen hastanın genel durumu iyi, GKS 15, pupiller izokorik, IR +/- . Oda havasında satürasyon yeterli mekanik ventilatör desteğinde; dinlemekle her iki akciğer solunum sesleri kaba ve bilateral azalmış. TA 126/74 mmHg, nabız 80/dk, ateş 36.7 C. Laboratuvar: lökosit 7900, CRP 40, kreatinin 1.5, üre 70, laktat 1.1, trombosit 290000. Vazopressör ihtiyacı yok, hemodinamik stabil. Antibiyoterapi enfeksiyon hastalıkları onayıyla Meronem 3x1gr (9.gün), Kolistin 3x150mg (5.gün). Kan gazı: ph 7.41 pco2 41 po2 96 hco3 25 be 1 spo2 98 sodyum 139 potasyum 4.0. Kan şekerleri 120-160 mg/dl seyretti, kristalize insülin ile regüle edildi. İdrar çıkışı diüretik infüzyonu ile yeterli, AÇT +180/24saat, CVP +1. Oral alımı iyi, mobilize. Solunum fizyoterapisi, vücut ve kateter bakımları yapıldı. Mevcut medikal, hemodinamik ve solunum destek tedavisine devam edildi.

GLASGOW Skalası Gözler : 4 Sözel : 5 Motor : 6